

• 标准与规范 •

艾滋病合并高脂血症中西医协同治疗专家共识^{*}

中华中医药学会防治艾滋病分会

摘要: 艾滋病高脂血症是指人类免疫缺陷病毒(human immune deficiency virus,HIV)/获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome,AIDS)患者采用高效抗反转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy,HAART)后出现血脂异常,主要表现为脂肪分布异常。西医治疗的常用药物有他汀类、贝特类、烟酸类等。根据临床症状中医称之为艾滋病血浊,中医认为主要与脾、肝、肾有关。临床实践证实中西医协同治疗艾滋病高脂血症具有显著临床疗效和优势。
文献引用: 中华中医药学会防治艾滋病分会. 艾滋病合并高脂血症中西医协同治疗专家共识 [J]. 中医学报,2020,35(8): 1673-1675.

关键词: 艾滋病; 高效抗反转录病毒疗法; 艾滋病高脂血症; 艾滋病血浊; 协同治疗; 专家共识

DOI: 10.16368/j.issn.1674-8999.2020.08.376

中图分类号: R259.129.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-8999(2020)08-1673-03

Expert Consensus on Chinese and Western Medicine Cooperative Treatment of AIDS Combined with Hyperlipidemia

AIDS Prevention Branch of Chinese Society of Traditional Chinese Medicine

Abstract: AIDS hyperlipidemia refers to the dyslipidemia followed by the use of highly active antiretroviral therapy (HAART) in patients with human immune deficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS), which is mainly manifested as abnormal fat distribution. Commonly used drugs for Western medicine treatment include statins, fibrates, and niacin. According to clinical symptoms, Chinese medicine is called AIDS blood turbidity, and Chinese medicine believes that it is mainly related to spleen, liver and kidney. Clinical practice in recent years has confirmed that Chinese and Western medicine synergistic treatment of AIDS hyperlipidemia has significant clinical efficacy and advantages.

Reference citation: AIDS Prevention Branch of Chinese Society of Traditional Chinese Medicine. Expert Consensus on Chinese and Western Medicine Cooperative Treatment of AIDS Combined with Hyperlipidemia [J]. Acta Chinese Medicine, 2020, 35(8): 1673-1675.

Keywords: AIDS; highly effective antiretroviral therapy; AIDS hyperlipidemia; AIDS blood turbidity; collaborative treatment; expert consensus

艾滋病高脂血症是指人类免疫缺陷病毒(human immune deficiency virus,HIV)/获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome,AIDS)患者采用高效抗反转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy,HAART)后出现血脂增高,包括高胆固醇血症、高三酰甘油血症、混合型高脂血症。低密度脂蛋白血症、高密度脂蛋白血症未纳入本共识研究范畴。艾滋病高脂血症最早于HAART治疗4周后即可

发生^[1],平均发病时间2~6年。研究表明,国外HAART治疗后高脂血症的发病率为47%左右^[2],国内研究为50%(11%~83%)^[3]。出现高脂血症与HAART开始治疗的年龄、基础胆固醇水平、初始治疗时使用司坦夫定和蛋白酶抑制剂密切相关。

艾滋病高脂血症中医称之为艾滋病血浊,中医认为HAART治疗后高脂血症主要与脾、肝、肾有关,由于脾胃受损、痰浊内生,或肝失疏泄、气机郁滞,或肾虚体衰、水湿不化,导致痰瘀积聚血脉引起血脂升高^[4]。临床实践证明中医药治疗艾滋病高

* 基金项目: 中医药行业科技专项项目(201507005)

脂血症有一定的临床疗效和优势^[5-8]。

1 临床表现

艾滋病高脂血症临床主要表现为脂肪分布异常: ①周围性皮下脂肪萎缩: 多见于面部、四肢及臀部; ②向心性脂肪堆积: 多见腹部、胸部、颈部、背部, 形成所谓水牛背及脂肪瘤。

HIV 病毒检测: 包括 HIV 抗体检测、HIV 核酸测定(病毒载量检测)、HIV 病毒分离培养以及 HIV 确证试验(WB)。

血脂检测: 总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇为最基本的血脂。

2 诊断要点

2.1 疾病诊断

2.1.1 艾滋病诊断标准 参照中华人民共和国国家标准《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》(WS293-2019)、中华医学会感染病学分会艾滋病学组制定的《中国艾滋病诊疗指南(2018版)》。

诊断原则: HIV/AIDS 的诊断需结合流行病学史(包括不安全性生活史、静脉注射毒品史、输入未经抗 HIV 抗体检测的血液或血液制品、HIV 抗体阳性者所生子女或职业暴露史等)、临床表现和实验室检查等进行综合分析, 慎重作出诊断。

诊断 HIV/AIDS 必须是 HIV 抗体阳性(经确证试验证实), 而 HIV-RNA 和 P24 抗原的检测有助于 HIV/AIDS 的诊断。

2.1.2 高脂血症诊断标准 参照中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会 2016 年制定的《中国成人血脂异常防治指南》血脂异常简易临床分型: 高胆固醇血症: 血清总胆固醇增高 $>5.72 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ (正常值上限), 三酰甘油正常; 高三酰甘油血症: 血清三酰甘油增高 $>1.70 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ (正常值上限), 总胆固醇正常; 混合型高脂血症: 血清总胆固醇和三酰甘油含量均增高, 即总胆固醇 $>5.72 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, 三酰甘油 $>1.70 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$; 低高密度脂蛋白血症: 血清高密度脂蛋白胆固醇降低 $<1.2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ (正常值下限)。

2.2 证候诊断 参照中华中医药学会心病分会 2008 年制定《血脂异常中医诊疗标准》。高脂血症主要属于中医“血浊”范畴。

肝郁脾虚证: 胸胁胀满或窜痛, 时欲太息, 情志抑郁或急躁易怒, 食欲不振, 乏力, 头晕, 纳呆, 恶心, 腹胀便溏, 或发作性腹痛腹泻。舌体胖大有齿痕, 苔

白或腻, 脉弦细或濡缓。

痰浊阻遏证: 形体肥胖, 头重如裹, 胸闷, 呕恶痰涎, 肢麻沉重, 心悸, 失眠, 口淡, 食少。舌胖, 苔滑腻, 脉弦滑。

气滞血瘀证: 胸胁胀闷、走窜疼痛或刺痛, 心烦不安。舌尖边有瘀点或瘀斑, 脉沉涩。

脾肾阳虚证: 畏寒肢冷, 眩晕, 倦怠乏力, 便溏, 食少, 脘腹作胀, 面肢浮肿。舌淡质嫩, 苔白, 脉沉细。

肝肾阴虚证: 眩晕耳鸣, 腰酸膝软, 五心烦热, 口干, 健忘, 失眠。舌质红, 少苔, 脉细数。

3 治疗原则和方案

3.1 西医治疗 HIV/AIDS 患者接受 HAART 可导致脂代谢紊乱, 引起高脂血症。患者出现高脂血症后应立即给予治疗。西医治疗高脂血症的常用药物有他汀类: 如洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等; 贝特类: 如苯扎贝特、非诺贝特、吉非罗齐等; 烟酸类: 如氧甲吡嗪等。

3.2 中医治疗

3.2.1 辨证治疗 肝郁脾虚证: 治法: 疏肝健脾。推荐方药: 逍遥散加减^[4,7] (证据级别 I, 推荐级别 A)。组成: 柴胡、郁金、当归、党参、白术、丹参、茯苓、山楂、甘草、赤芍等。中成药: 逍遥丸^[8-9] (证据级别 II, 推荐级别 C)、加味逍遥丸^[10-11] (证据级别 II, 推荐级别 C)。

痰浊阻遏证: 治法: 燥湿祛痰。推荐方药: 二陈汤加减^[7,12] (证据级别 I, 推荐级别 A)。组成: 陈皮、半夏、茯苓、薏苡仁、苍术、白术、厚朴。中成药: 血脂康胶囊^[13-14] (证据级别 I, 推荐级别 A)、脂必泰胶囊^[15-16] (证据级别 II, 推荐级别 C)。

气滞血瘀证: 治法: 行气活血。推荐方药: 血府逐瘀汤加减^[7,17] (证据级别 I, 推荐级别 A)。组成: 桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、生地黄、牛膝、柴胡、枳壳、郁金、桔梗。降脂颗粒^[18-19] (协定处方): 赤芍、川芎、黄芪、郁金、虎杖、法半夏、决明子、山楂、泽泻、丹参 (证据级别 I, 推荐级别 A)。中成药: 血府逐瘀片^[20] (口服液) (证据级别 II, 推荐级别 C)。

脾肾阳虚证: 治法: 温补脾肾。推荐方药: 附子理中汤加减^[21] (证据级别 I, 推荐级别 B)。组成: 制附子(先煎)、人参(另煎兑服)、白术、炮姜、炙甘草、茯苓、桂枝。艾脂 1 号方(协定处方)^[22] (证据级别 III, 推荐级别 D): 鹿角胶、淫羊藿、生黄芪、生薏苡仁、生山楂、丹参、泽泻。中成药: 附子理中丸(证

据级别Ⅲ,推荐级别D)、金匱肾气丸^[23-24]等(证据级别Ⅱ,推荐级别C)。

肝肾阴虚证:治法:滋补肝肾。推荐方药:杞菊地黄丸加减(无相关报道)。组成:生地黄、山药、茯苓、山萸肉、牡丹皮、泽泻、枸杞、菊花。中成药:杞菊地黄丸(无相关临床报道)、壳脂胶囊^[23](证据级别Ⅲ,推荐级别D)。

3.2.2 其他疗法

3.2.2.1 耳穴 取穴:饥点、口、脾、内分泌、肾、直肠下等穴,或取敏感点。手法:用王不留行籽或白芥子取穴。2 d换药1次,换药3次休息2 d,为1周期。7个周期为1个疗程。

3.2.2.2 艾灸 取穴:丰隆、足三里、巨阙、天枢、脾俞、肝俞、神阙。方法:将点燃的艾条悬于所需施灸的穴位上,距离皮肤约3 cm,灸至皮肤温热发红,有温热感为宜。一般每穴灸10 min左右即可。或用艾灸仪。

3.2.2.3 推拿 穴位推拿:内关、屋翳、渊腋、辄筋、肾俞、膏肓等,重点揉左侧穴位,每穴揉30次;肾虚者选择加揉三阴交、涌泉穴、中脘、天枢、气海、脾俞、胃俞、足三里等;痰浊者选择加揉天突、膻中等。

3.2.2.4 气功 如五禽戏、太极拳等调和气血,调理脏腑降血脂。

执笔单位:首都医科大学附属北京佑安医院、河南中医药大学第一附属医院、中国中医科学院艾滋病中心

中华中医药学会防治艾滋病分会参加本共识讨论及编写的成员名单:(按姓氏笔画排序)邓鑫、卢洪洲、冯全生、刘建忠、刘颖、许前磊、苏琛、李秀惠、李鹏宇、李鑫、陆中云、杨玉琪、杨毅、何云、何金洋、何艳、谷野、邹雯、张传涛、张国梁、张明香、张晓忠、张毅、陈昕、陈耀凯、邵宝平、林路平、罗威、和丽生、胡建华、姜枫、徐立然、高辉、高国建、郭会军、黄成瑜、常占杰、梁碧颜、董继鹏、蒋士卿、喻剑华、谭行华、蔡怡

参考文献:

- [1] 中国中医科学院中医药防治艾滋病研究中心. 艾滋病中医药治疗手册[M]. 北京:中医古籍出版社,2014:61-70
- [2] JEVTOMI D J, DRAGOMIR G, SALEMOVI D, et al. The metabolic syndrome, an epidemic among HIV-infected patients on HAART[J]. Biomedicine Pharmacother, 2009, 63(5): 337-342.
- [3] 郭会军, 李鹏宇. 艾滋病高效抗反转录病毒治疗后高脂血症的临床研究进展[J]. 时珍国医国药, 2010, 21(7): 1761-1762.
- [4] 薛柳华, 黄世敬, 潘菊华, 等. 高效抗反转录病毒治疗相关高脂血

症中医诊疗概述[J]. 北京中医药, 2011, 30(5): 398-400.

- [5] 戚庆飞, 刘颖, 邹雯, 等. 中医治疗 HAART 继发性高脂血症的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(15): 2530-2533.
- [6] 胡建华, 李秀惠, 刘颖, 等. HAART 后 HIV/AIDS 脂肪代谢障碍综合征临床研究进展与展望[J]. 中国医学创新, 2014, 11(3): 136-139.
- [7] 代三红. 中医辨证治疗非酒精性脂肪肝 516 例[J]. 陕西中医, 2011, 32(11): 1478-1479.
- [8] 刘小军, 陈彦. 逍遥丸治疗非典型抗精神病药物所致高脂血症疗效观察[J]. 医学信息, 2016, 29(16): 377-378.
- [9] 尹柱汉, 董倩. 古方加减治疗高脂血症[J]. 河南中医, 2001, 21(2): 37-38.
- [10] 何召叶. 逍遥散加味治疗脂肪肝 86 例[J]. 环球中医药, 2012, 5(9): 702-704.
- [11] 吴建业, 周继旺, 高明. 加味逍遥散治疗非酒精性脂肪肝临床观察[J]. 浙江中医杂志, 2014, 49(11): 842.
- [12] 仇云鹏, 彭宪立. 逍遥散合二陈汤治疗脂肪肝 100 例临床观察[J]. 基层医学论坛, 2016, 20(32): 4584.
- [13] 王卫霞, 陈可冀. 血脂康胶囊治疗高脂血症有效性和安全性的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2006, 6(5): 352-360.
- [14] 李辉, 李晓华, 李国立. 血脂康胶囊治疗青年高脂血症 135 例疗效观察[J]. 医学研究生学报, 2009, 22(10): 1042-1044.
- [15] 项维. 脂必泰胶囊治疗血脂异常 40 例疗效观察[J]. 湖北科技学院学报(医学版), 2013, 27(4): 320-322.
- [16] 何岳. 辛伐他汀与脂必泰胶囊治疗单纯高脂血症的效果比较[J]. 右江医学, 2013, 41(6): 854-856.
- [17] 陈苏宁, 杨积武, 张放, 等. 血脂康胶囊加减治疗高脂血症 100 例[J]. 辽宁中医杂志, 2001, 28(6): 364-365.
- [18] 王士兵, 王永年, 徐珑嫣, 等. 降脂颗粒治疗不同中医证型高脂血症的疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2016, 25(34): 3808-3809.
- [19] 陈旭, 褚宏伟. 活血降脂颗粒治疗肾虚血瘀型原发性高脂血症患者血脂变化分析[J]. 中医临床研究, 2015, 7(32): 49-50.
- [20] 陆新. 血脂康口服液治疗高脂血症 50 例[J]. 广西中医学院学报, 2003, 6(3): 22-23.
- [21] 谭茂卿. 从“治未病”思路用中医温阳健脾法治疗脂肪肝临床疗效分析[J]. 北京: 第六届中和亚健康论坛暨中华中医药学会亚健康分会年会论文集, 2013: 203-206.
- [22] 李秀惠, 王芳梅, 高艳清, 等. 艾脂 I 号治疗艾滋病 HAART 后脂肪异常分布临床观察[J]. 中国艾滋病性病, 2010, 16(3): 226-228.
- [23] 王宜健, 彭秀芳, 熊伟, 等. 金匱肾气丸合血脂康胶囊治疗老年高脂血症脾肾阳虚型临床研究[J]. 实用中医药杂志, 2014, 30(8): 694-695.
- [24] 朱伟旗. 金匱肾气丸治疗 II 型糖尿病并发高脂血症 18 例[J]. 中国中医药现代远程教育, 2013, 11(15): 96-97.
- [25] 彭玲, 向光明, 何元军, 等. 壳脂胶囊在高脂血症合并脂肪肝治疗中的作用[J]. 西部医学, 2008, 20(1): 141-142.

收稿日期: 2020-02-10

编辑: 纪彬